Patricie Moučková r.č.
poj.211

Prosím laskavě o konzultaci CT mozku a srovnání s MRI. Dle CT mozku 8/2026 Parietálně vlevo pod kalvou kalcifikovaný meningeom vel. 12 x 9 mm.
Dle MRI mozku 8/2025 Vlevo parietálně je podél kalvy drobné stacionární extraaxiální lentikulární T2 hyposignální ložisko vel. 10x6 mm

Klinicky lucidní, oritnována, spoupracuje, MN norm, bez parezy, mobilnjí samostatně. areflexie na dkk, po TEP kyčle vlevo Bez epi.

CT vyšetření mozku - nativ + postkontrastně - Ultravist 100 ml i.v,, šarže IUIAV4V2C (MUDr.Walach, 19.8.2026)
Oblast zadní jámy lební bez ložiskových změn, struktury bez deviace. Bazální ci$terny symetrické, přiměřené.
Parietálně vlevo pod calvou kalcifikovaný meningeom vel. 12 x 9 mm.
Bilá i šedá hmota mozková přiměřené denzity, bez ložiskových změn, bez krvácení.
Struktury střední čáry bez deviace, komorový systém symetrický, přiměřený.
Subarachnoidální prostory na konvexitě přiměřené. Skelet kalvy bpn.
Bez čerstvých ložiskových změn v CT obraze mozku. Bez průkazu meta po kl.
CTA extrakraniálních magistr'álních a intrakraniálních tepen mozku - Ultravist 100 ml i.v., šarže ltHAV4V2C Tepny odstupuji z oblouku aorty v normálním pořad i. Truncus brachiocephalicus a obě podklíčkové tepny v zobrazeném úseku bez stenosy či uzávěru Obě ACCa ACE maji normální průběh a šíň ve všech projekcích, bez významných změn. Odstupová stenoza ACI vlevo do 30 %, v dalším průběhu obě ACI volně průchodné.
Vertebrální tepny symetrické, v zobrazeném úseku bez odchylek, tepny jsou průchodné v celém rozsahu.
Tepny intrakraniálního tepenného řečiště normálně utvářené, kompletní Willisův okruh.
Intrakraniální průběh AC;I bez změny, normální odstupy i průběh AC:A, ACM - do periferie.
ACP 1. sin se plní cestou zadní komunikanty.
A. basilaris i obě ACP do úrovně P2 včetně bez změny.
Vidi MUDr. Cibulková

MR mozku -nativ-21.8.2025 Vlevo parietálně je podél kalvy drobné stacionární extraaxiální lentikulární T2 hyposignální ložisko vel. 10x6 mm, Závěr:Supratentoriálně ojedinělá drobná ložiska gliozy v bílé hmotě bilat-nejspíše postschemické mikrovaskulární etiologie.Vlevo parietálně je drobné stacionární extraaxiální ložisko - v.s. drobný meningeom.
Ve srovnání s předch. MR vyš. mozku z 10/2023 nález bez změny.

souhrn dg
Ré: Akutní závrat, v.s. periferní 8/2026- neurol. vyš. KHN 8/2026, CT mozku a CTAG výše - regrese potíží Chron.lumbalgie, regred.levostranné lumbofemoralgie autoderm L4 vlevo, koincidence koxalgie levostr-pseudoradikul. sympt. L4 vlevo aktuálně bez myeloradikulopatie. Stav po synkopě v.s. 7.6.2021- s kontuzí obličeje, dle CT 7.6.2021 Havířov fraktura NK a septa a náhodný nález meningeom P-O vlevo (konzervat.dle NCH) bez

přesvědčivé klinicky svědčící pro epi. Kardiologicky vyšetřena, stran rytmu stabilní, zachyt jen asympt. SVES MRI mozku 9/2021 a výše Vlevo parietálně menší TU ložisko- charakteru meningemomu.
Oboustranně několik drobných ložisek gliozy v paraventrikulární bílé hmotě, nejspíše postischemické etiologie. EEG 3.11.2021 bez fokality Smíšená převážně axon. senzimotorická PNP dkk lehkého až středně těžšího stupně EMG 6/2020 + RLS v.s. neuropatická bolest Postchemoterapeutická ?? gabapentin bez efektu .. Parestezie HKK v.s. cervikogenní , neuropatie nn. HKK nezjištěna. Ca prsu vyřazena t.č. z disp. onkologie v r. 2002 extripace TU l. prsu, stp. opak. extirpace TU l.sin v 4/2003 + exenterace uzlin z levé axily, RT 2003, CHT 2003-2004, tč. remise.
Tachyfibrilace síní , parox. tachyarytmie od léta 2017 Stav po katetrové ablaci parox. FiSi- obkružující léze 2/2019
Koxartrosa bilat, gr.III bilat - stav po TEP kyčle vlevo 14.10.2020 vedena na ortopedii. Calcar calcanei vedena na chir. amb.
Hypertenze, Astma bronchiale, rhinitis chorn. dyslipidemie, Sled. na alergologii pro astma. Sled. od r. 2008 do r.2015. V r. 1992 - HYE + OE bil. stav po zlomenině dx bérce 1976 + OS, extrakce kovu, stav po zlomenině zlomeniny v zápěstí r-1975, stav po APPE, stav po extirpaci znamének na břiše a na zádech - negativní-.
VCHGD v anamn.
Omartrosis l.dx.